

03 - 03- Diagnostic d'une hanche douloureuse - Pr Niamane

Bonjour, on va parler aujourd'hui sur le diagnostic d'une hanche douloureuse. Je vous laisse découvrir les objectifs pédagogiques. Il faut savoir effectuer un examen programmé de la hanche, connaître les éléments orientés de diagnostic vers une atteinte articulaire, connaître les différents tableaux cliniques, c'est-à-dire faire la différence entre une hanche douloureuse mécanique et une hanche douloureuse inflammatoire et citer les principales étiologies.

En guise d'introduction, la douloureuse de la hanche est un motif de consultation assez fréquent en médecine générale. C'est une articulation qui est particulière, c'est une articulation qui est profonde et son exploration clinique est difficile. Donc on aura besoin souvent de faire une radiographie du bassin.

C'est une articulation qui est portante, qui permet à la personne de se mettre debout, de se mettre assise, de marcher, de faire du sport. Et donc les étiologies vont être dominées par la pathologie de l'articulation coxion-fémorale. La pathologie abarticulaire de la hanche est le plus souvent satellite.

C'est ce qui fait la différence avec une douleur de l'épaule ou on a plutôt l'inverse. La pathologie de l'articulation glénohumérale, il est beaucoup plus rare par rapport à la pathologie abarticulaire de la coiffe du rotateur. La pathologie mécanique est dominée par la coxarthrose.

La pathologie inflammatoire de l'articulation coxion-fémorale est appelée coccyte. Les coccytes sont généralement infectieuses. Lorsqu'ils sont chroniques, en Maroc, ils sont dus habituellement à une tuberculose.

Sinon, il s'agirait de coccytes rhumatismales, plus souvent en rapport avec une spondyloarthrose. En guise de rappel anatomique, il faut faire la différence d'emblée entre la hanche et l'articulation coxion-fémorale. La hanche est une région anatomique qui lie le membre inférieur au tronc et ne veut pas dire du tout douleur de l'articulation coxion-fémorale.

Un patient qui consulte pour une douleur de la hanche, ça peut être une douleur en rapport avec l'articulation coxion-fémorale, ou bien ça peut être une douleur d'une origine autre qui peut prendre naissance au niveau des éléments anatomiques qui entourent l'articulation coxion-fémorale. Dans ce topo, on va essayer de vous montrer comment on va rapporter une douleur de la hanche à l'atteinte de l'articulation coxion-fémorale. Tout ce qui n'est pas lié à l'atteinte de cette articulation va être considéré comme étant un diagnostic différentiel.

L'articulation coxion-fémorale est composée de deux surfaces articulaires qui sont très bien congruentes, bien stabilisées par la présence d'un bourrelet glénoïdien qui permet à cette articulation d'être stable pour assurer la station de goût et la marche. L'articulation est entourée par la capsule articulaire. Tout ce qui est intracapsulaire est dit articulaire.

Dans cette articulation, on va trouver l'extrémité supérieure du fémur, la tête fémorale, qui est couverte par le cartilage articulaire avec la membrane synoviale, le liquide synovial. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'atteinte articulaire, le cartilage, la synoviale et l'os épiphysère vont représenter la grande majorité des idéologies de l'atteinte de l'articulation coxion-fémorale. Tant qu'on se résume sur cette diapositive, les douleurs de la hanche sont souvent d'origine intra-articulaire, c'est-à-dire qu'elles prennent naissance de l'articulation coxion-fémorale.

Les trois autres chapitres vont être des diagnostics différentiels, à savoir les douleurs péri-articulaires en rapport avec une atteinte des éléments musculotendineux qui sont les tendinopathies, les douleurs locales qui prennent naissance des structures osseuses du voisinage, comme par exemple une lésion qui intéresse le grand trochanter ou le cotyle, ou des éléments vasculonerveux qui passent devant ou derrière l'articulation, ou bien il peut s'agir de douleurs projetées, référées ou irradiées venant d'une région anatomique un peu plus loin, comme l'orachis, ou l'articulation du voisinage, la sacroiliac ou la cerfise pubienne. Pour le diagnostic positif, il faut interroger le patient et on va passer à l'examen programmé de l'articulation. A l'interrogatoire, le maître symptôme étant la douleur.

Cette douleur est localisée habituellement au niveau de la région inguinale, c'est-à-dire au niveau du pli de l'aîne, et il peut irradier parfois à la face antérieure de la cuisse, et cette irradiation peut parfois arriver jusqu'au genou, ce qu'on appelle la douleur pelvique rale. Rarement, cette douleur peut se situer dans la fesse ou à la face externe du grand trochanter. Et plus rarement encore, l'atteinte de l'articulation corsofémorale peut se manifester uniquement par une douleur isolée du genou.

C'est la raison pour laquelle un patient qui consulte pour une douleur du genou, il faut automatiquement examiner la hanche. Alors cette douleur, selon l'étiologie, peut être mécanique ou inflammatoire, aiguë ou chronique. Il faut toujours évaluer le retentissement fonctionnel de l'atteinte de l'articulation corsofémorale parce que la douleur va engendrer une perte de la fonction de cette articulation.

Et nous avons des indices qui permettent d'évaluer son retentissement. Et on va vous faire montrer un exemple d'indice composite qu'on appelle l'indice algophonctionnel de Leuken qui a été validé dans la Coxarthrose. C'est un auto-questionnaire qui est rempli par le malade lui-même et qui permet de donner une cotation que vous voyez sur la colonne de droite en fonction de l'intensité du paramètre à mesurer.

Et nous avons sur cet indice algophonctionnel trois domaines, la douleur, la marche, c'est-à-dire le périmètre de marche ou la marche maximale et un dernier domaine qui est la difficulté pour effectuer les gestes de la vie quotidienne. A titre d'exemple, le patient peut compter 1 à 2 pour la douleur. Pour la marche maximale, il peut donner 6 points si il n'arrive pas à faire plus de 100 m. Il peut ajouter 1 point si il marche avec une canne, 2 points s'il utilise 2 cannes et pour les gestes de la vie quotidienne, il va mettre 0, 1 ou 2 points en fonction des difficultés qu'il trouve à enfilier

chaussettes ou collants par devant, à ramasser un objet par terre, à monter ou à descendre un étage, sortir d'une voiture ou avoir un retentissement sur l'activité sexuelle.

Cet indice fonctionnel va de 1 point à 24 points et à partir de 10-12 points, on peut conclure que le patient a un retentissement important que le handicap est important. Habituellement, dans la coxarthrose, les patients qui ont plus de 12 points sont généralement des candidats à la chirurgie. Pour l'examen clinique, il est dit programmé parce qu'il est effectué de la manière suivante et toujours chez tous les patients, d'abord en position debout, puis par la suite à la marche puis enfin on va le faire en decubitus chez un patient allongé sur une table d'examen de manière comparative.

En position debout, il faut faire attention aux éléments suivants. Il faut voir si le patient a une amyotrophie du quadriceps qui s'installe assez rapidement lorsqu'il y a une atteinte de l'articulation coxophomorale. Chercher s'il a des attitudes vicieuses lorsqu'il y a une atteinte structurelle de l'articulation.

De profil, on peut voir un patient en flexion et de face on peut observer parfois une attitude en rotation externe du membre inférieur et un raccourcissement d'un membre par rapport à l'autre objectivé par un non-alignement des crêtes iliaques. Cet genre d'anomalie est observé lorsqu'il y a une atteinte sévère de l'articulation coxophomorale. Enfin, on peut reproduire la douleur de l'articulation coxophomorale en demandant au patient de faire un appui monopodal c'est à dire à se mettre debout sur un seul membre inférieur.

La deuxième partie de l'examen, on va faire marcher le patient et à la marche il faut chercher s'il y a une boiterie. Il y a plusieurs types de boiterie lorsqu'il y a une atteinte de l'articulation coxophomorale. Le premier type de boiterie est la boiterie par esquive du pas qui est causée par la douleur.

Donc le patient va esquiver au moment de l'appui pour éviter d'avoir mal. Le deuxième type de boiterie peut être en rapport avec une raideur débutante au niveau de l'articulation coxophomorale qui va intéresser surtout la rétropulsion de l'articulation et va avoir une perte du pas postérieur lors de la marche. Et puis un troisième type de boiterie c'est lorsqu'on observe une amyotrophie qui touche les muscles du moyen fessier du côté atteint.

Si bien que le côté contralatéral va tirer vers le haut et va donner comme le montre ce schéma un non-alignement des crêtes iliaques avec bascule vers le côté opposé ce qui donne une boiterie assez particulière qu'on appelle le signe de traîne des limbaux. En position couchée on va chercher l'amyotrophie du quadriceps en mesurant le périmètre du quadriceps des deux côtés à 15 cm au dessus du bord supérieur de la ventile qu'on va consigner pour la surveillance. Mettre en évidence un épanchement articulaire est très difficile du fait que l'articulation est profonde et couverte par des masses musculaires importantes.

On va terminer cet examen par l'étude des manoeuvres passives et actives. Ces mesures

goniométriques de la mobilité articulaire sont très importantes car elles mettent en évidence la raideur articulaire définie par la limitation de la mobilité articulaire et ce qui va permettre de faire le suivi évolutif. Il faut mesurer la flexion qui est habituellement de 120 à 130 degrés L'extension va être faite comme le montre le schéma habituellement à 30 degrés La rotation externe et la rotation interne sont de 45 degrés en moyenne et puis on termine par l'abduction qui est à 30 degrés et l'abduction à 45 degrés.

Certains deux types de manoeuvres actives sont importants à connaître la manoeuvre du salicoxale et le syndrome clénostatique La manoeuvre du salicoxale comme le montre la photo le patient étant du cubitus dorsal le patient élève de manière active le membre inférieur en extension à 30 degrés au-dessus du plan du lit en présence d'une atteinte de la coxopathie cette manoeuvre réveille la douleur on dit que la manoeuvre du salicoxale est positive on peut sensibiliser ce test en imprimant une résistance au-dessus de la rotule deuxième manoeuvre active le syndrome clénostatique le syndrome clénostatique on va demander au patient de décoller le membre inférieur tendu du plan de lit et il est incapable de le faire à cause de la douleur qui survient au niveau du pli de laine l'existence du syndrome clénostatique traduit le plus souvent une pathologie qui siège au niveau du fond du cotyle à partir de notre examen clinique en se basant sur la mobilité passive et active on peut déjà élaborer une étiologie si la mobilité passive et active sont limitées il s'agit d'une raideur articulaire il s'agit d'une pathologie intra-articulaire si la mobilité passive et active sont normales et indolores habituellement ce n'est pas une atteinte de l'articulation croxophore morale il s'agit d'une lésion de vaginale si la mobilité passive est normale mais la mobilité active réveille la douleur habituellement c'est une tendinopathie c'est-à-dire une douleur péri-articulaire quels sont les examens complémentaires qu'il faut demander devant une once douloureuse d'abord les radiographies standards le plus souvent on demande des clichés qui permettent d'orienter le diagnostic il faut demander une radiographie de bassin de face qui permet l'analyse des articulations croxophore morale de manière comparative et faire parfois des mesures coxométriques dont on a besoin pour chercher une éventuelle dysplasie de la hanche parfois comme vous le voyez sur la photo on peut demander une radiographie centrée sur la hanche de face et enfin on peut demander ce qu'on appelle un faux profil de lequel ce n'est pas un vrai profil de la hanche mais c'est un faux profil de la hanche qui permet d'examiner l'interline articulaire à sa partie postérieure et postéro-inférieure et entéro-supérieure la partie postérieure de l'interline articulaire n'est pas bien visible sur une radiographie du bassin de face il faut demander le faux profil de lequel les autres examens complémentaires d'imagerie qu'on peut également demander nous avons l'échographie articulaire qui permet de rechercher souvent un éplanchement ou bien de faire la ponction écho-guidée de l'articulation croxophore morale lorsqu'il y a un liquide qu'on veut analyser il permet également d'étudier les tendons qui entourent cette articulation le scanner est demandé lorsqu'on veut chercher une pathologie osseuse, bénigne ou maligne l'arthrographie couplée au scanner permet d'étudier l'articulation dans certaines étiologies comme lorsqu'on veut chercher un corps étranger intra-articulaire une pathologie du bourrelet cotylhuidien une pathologie de la membrane

synoviale ou lorsqu'on veut chercher une chondropathie débutante une pathologie du calculage articulaire débutant l'IRM est très importante dans l'exploration surtout des douleurs de la hanche avec des radiographies standard c'est à dire qu'on veut mettre en évidence des pathologies qui sont débutantes invisibles sur la radiographie standard et souvent il s'agit de pathologies osseuses il y a donc l'IRM, il y a l'AIDA un apport important lorsqu'on veut chercher une osteonecrose asyptique, une algodistrophie ou une coccyte débutante enfin la scintigraphie permet également de mettre en évidence des pathologies osseuses comme une osteonecrose asyptique de la hanche ou une algodistrophie mais il est de moins en moins demandé parce qu'il a été suppléé par l'IRM les examens biologiques qu'il faut demander habituellement on demande un bilan inflammatoire une vitesse de sédimentation un séro-réactif protéine, une numération 3100 leucocytes et l'étude du liquide articulaire lorsqu'on arrive à faire une fonction écho-guidée ou radio-guidée et les autres bilans vont être demandés en fonction de l'étiologie suspectée les diagnostics différentiels sont en fait les pathologies c'est une douleur de la hanche en dehors de l'actuation coccyfèbre et dans ce cas l'examen va mettre en évidence que la mobilité passive et active sont strictement normales ou bien que la mobilité passive est normale et c'est la mobilité active uniquement qui est douloureuse qui est en rapport avec l'endomyopathie de la hanche donc le diagnostic différentiel qu'il faut connaître devant une douleur de la hanche et ça c'est très important ce sont surtout les lombocloralgies L3 et L4 ce sont les radiculalgies qui prennent naissance au niveau du rachis lombaire et qui vont irradier dans le trajet L3 ou L4 c'est-à-dire qui vont passer devant la hanche le long de la cuisse à sa face antérieure qu'on verra en détail dans le cours des radiculalgies les lombociliatiques à trajet tronqué c'est-à-dire que ce sont les douleurs radiculaires dans le trajet du ciliatique mais qui restent tronquées au niveau de la fesse et on a vu qu'une douleur de la hanche peut être révélée par une douleur fessière alors dans ce cas-là on va voir que l'articulation de la hanche est tout à fait indolore à la mobilité passive et active et c'est l'examen du rachis lombaire l'examen neurologique qui va mettre en évidence des anomalies à l'examen il y a une articulation qui est juste à côté de l'articulation de la hanche c'est l'articulation sacroiliaque une atteinte de la sacroiliaque qui soit d'origine rhumatismale ou infectieuse peut donner une douleur au niveau de la hanche plus rarement au niveau de la symphyse pubienne alors toute atteinte onéuse de voisinage peut donner une douleur au niveau de la hanche ça peut être une fissure, une fracture une tumeur bénigne ou maligne qui peut toucher la région ischio-iliopubienne l'iliac, le côtyle ou le col fémoral voire le grand trochanter et là c'est la radiographie du voisin qui va montrer cette lésion sachant que dans ce cas-là la mobilité passive et active de l'articulation est strictement normale la tendinopathie de la hanche dans ce cas-là vous avez une mobilité active qui est douloureuse et une mobilité passive qui est strictement normale et indolore ça on va le développer dans la pathologie abarticulaire devant nous avons un tendon qui est le psoas iliac qui s'insère au niveau du petit trochanter en latéral nous avons les muscles moyens fessiers en médial ce sont les adducteurs et en postérieur nous avons l'insertion des ischiosomies enfin les douleurs d'origine viscérale qui sont importantes à connaître et qui on ne retrouve uniquement que à l'examen clinique complet somatique c'est la tête vasculaire, la présence d'une adénopathie inguinale voire d'une hyalie

inguinale qui peut donner également une douleur au niveau de la hanche le diagnostic étiologique va être évoqué en fonction du caractère de la douleur la douleur soit elle est mécanique soit il s'agit d'une douleur inflammatoire alors une douleur mécanique de la hanche oriente vers trois diagnostics principaux qui sont la coxarthrose, l'ostéonécrose aseptique et l'algodystrophie, les autres diagnostics à évoquer sont l'ostéocondromatose et la condromatose synoviale et la synovite villonodulaire alors la coxarthrose va être détaillée dans le chapitre de l'arthrose l'ostéonécrose aseptique de la hanche donc c'est une pathologie osseuse qui touche l'os épiphysaire de la tête fémorale donc c'est une nécrose de l'os épiphysaire de la tête fémorale par une ischémie aiguë qui entraîne la mort cellulaire je vous rappelle que la vascularisation de la tête fémorale est terminoterminal assurée par une petite artère qui est l'artère circumflexe lorsqu'il y a une ischémie au niveau de cette artère on peut avoir une ischémie aiguë et une mort cellulaire de la tête fémorale et donc la tête fémorale finit par perdre sa sphéricité à cause de la nécrose et il va donner habituellement une douleur d'apparition brutale sur la radiographie nous avons une classification appelée classification de Harris efficace en 4 stades qui permettent de mettre en évidence les 4 stades évolutifs de l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale donc vous voyez sur la radiographie en bas le stade 1 la radiographie est strictement normale c'est à ce moment là où devait y avoir une douleur mécanique d'installation brutale avec une radiographie normale on peut évoquer ce diagnostic et le faire grâce à l'IRM le stade 2 ce sont des petites images qu'il faut voir vraiment de très près lorsqu'on examine une radiographie du bassin sur le négatoscope on va observer cette image de l'ISRE qu'on appelle une image en copie 2 qui est un décollement de l'os nécrosé par rapport à l'os sous-acétabulaire le stade 3 c'est un stade où la tête n'est plus sphérique donc il n'est plus qu'une congruente par rapport au cotyle et cette perte de la sphéricité de la tête fémorale se fait par un affaissement de la zone nécrosée et on voit un aspect en marche d'escalier avec un pseudo élargissement de l'interligne articulaire enfin le stade 4 c'est le stade où le patient est vu au stade de coxarthrose qui est le stade le plus tardif donc le diagnostic doit être précoce au stade radiologique où la radiographie du bassin est encore normale avant la perte de la sphéricité avant l'effondrement de la nécrose osseuse et la perte de la sphéricité parce qu'à partir de ce stade là il faut faire normalement une prothèse d'angle même si le sujet est encore jeune donc pour faire ce diagnostic de manière précoce on demande la stéthigraphie osseuse qui est un examen qui est sensible et qui n'est pas spécifique mais c'est l'IRN qui va mettre en évidence le secteur nécrosé comme vous le voyez sur cette iconographie Troisième iconographie d'une hanche bleueuse d'origine mécanique, c'est l'algodystrophie l'algodystrophie est une pathologie d'origine inconnue dont l'algodystrophie de la hanche, la douleur apparaît brutalement avec une importance fonctionnelle très importante au début les radiographies standards sont normales et tardivement on peut mettre en évidence une déminéralisation mouchetée de la tête fémorale avec un interligne articulaire qui reste indemne c'est une pathologie curieusement qui est assez fréquente chez la femme enceinte donc le diagnostic précoce on repose s'agissant d'une pathologie osseuse sur la stéthigraphie osseuse qui va mettre en évidence une hyperfixation précoce ou bien mieux encore l'IRN qui va montrer un hypersignal mal limité en séquence T1 et un hypersignal en T2 comme vous le voyez sur

cette iconographie bien sûr lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte c'est le seul examen qui nous est permis de réaliser la quatrième idéologie de la pathologie mécanique de la hanche c'est la chondromatose et la chondromatose synoviale alors c'est quoi la chondromatose ? la chondromatose c'est une métaplasie de la membrane synoviale qui entraîne la formation de structures cartilagineuses qui sont libérées dans la cavité articulaire la métaplasie c'est-à-dire la transformation d'un tissu en un autre tissu ici c'est la membrane synoviale qui va se transformer en cartilage, on l'appelle chondromatose ces structures qui sont libérées dans la cavité articulaire par la suite elles vont saucifier et on va les appeler ostéochondromatose ces corps étrangers qui sont en train de se balader dans l'articulation vont être responsables de la douleur d'une part, une douleur mécanique et parfois d'épisodes de blocage lorsqu'il y a un corps étranger qui bloque l'articulation ces corps étrangers sont cartilagineux, c'est une chondromatose les radiographies standards sont normales à moins qu'on ait observé une petite augmentation de l'épaisseur de l'interligne articulaire par rapport au côté sain et qui doit attirer l'attention c'est l'arthrographie couplée ou non au scanner qui permet de mettre en évidence ces chondromes parce qu'ils ne sont pas visibles sur la radiographie standard si ces corps étrangers sont ossifiés il s'agit d'une ostéochondromatose et là les radiographies standards les mettent en évidence plus facilement ce que vous voyez dans la partie d'éclive sur la radiographie à gauche vous voyez des petits ostéochondromes ce sont ces petites images qui sont arrondies et sur l'arthroscanère vous voyez ces images qui sont arrondies qui se baladent au niveau du liquide articulaire de l'articulation coxo-fémorale et vous voyez à quoi ils ressemblent lorsqu'on opère les patients dernière étiologie de la douleur mécanique c'est l'asinovite vésiculaire l'asinovite vésiculaire c'est une hyperplasie de la membrane synoviale donc c'est une synoviale qui devient surchargée au némo-sidérine ce qui lui donne un aspect brunâtre à l'examen macroscopique et lorsqu'on fait la ponction du liquide articulaire c'est un liquide qui est de couleur rouge-oranger on dirait bien que c'est un examen hématique les radiographies standards sont souvent normales parfois on peut observer des géodes juxta-articulaires c'est l'arthroscanère qui permet de faire le diagnostic de cette pathologie mais la confirmation se fait par la biopsie synoviale sinon par l'arthroscopie lorsqu'on opère sur les malades vous voyez ici une synovite vésiculaire et vous voyez le chirurgien qui a enlevé cette synoviale qui est hypertrophiée et qui a cet aspect brunâtre à cause de la surcharge en némo-sidérine alors maintenant pour une douleur de la hanche inflammatoire une douleur de l'articulation coxo-fémorale inflammatoire est appelée une coccyte une coccyte peut avoir plusieurs idéologies la première idéologie c'est les arthrites d'origine infectieuse c'est ce qu'il faut évoquer en priorité s'agissant d'une urgence médicale s'il s'agit d'une coccyte aiguë c'est souvent les coccytes infectieuses à germes piogènes et je vous ramène ici vers le cours de la monoarthrite aiguë qu'on a vu au début d'année lorsque la pathologie coccyte est d'origine chronique il faut évoquer surtout la tuberculose dans le contexte marocain ou bien la brucellose les autres coccytes, les coccytes rhumatismaux il s'agit en fait de malades qui vont développer un rhumatisme inflammatoire chronique avec une atteinte polyarticulaire mais qui commence d'abord par une atteinte monoarticulaire au niveau de la hanche ce qui donne le plus souvent une douleur inaugurale au niveau de la hanche c'est surtout la spondylarthrite ou le kélosante et le

rhumatisme psoriasique un peu moins la polyarthrite rhumatisme enfin vous avez les coccytes d'origine micro-crystalline ce sont souvent des coccytes qui sont en rapport avec des dépôts de pyrophosphate de calcium dans le caractère qu'on appelle la chondrocalcinose articulaire les coccytes d'origine goutteuse sont vraiment exceptionnels dans la chondrocalcinose on a deux modes évolutifs soit vous avez des patients qui arrivent avec une hanche hyper douloureuse, ce qu'on appelle des accès aigus pseudo-goutteux par libération de micro-crystaux de pyrophosphate de calcium dans l'articulation ce sont des accès qui ressemblent un peu à une crise de goutte qu'on appelle un accès pseudo-goutteux avec une douleur très intense avec une importance fonctionnelle majeure un syndrome fébrile qui peut exister et qui peut mimer une arthrite septique et d'ailleurs c'est un diagnostic différentiel avec l'arthrite pyogène le deuxième mode évolutif de la chondrocalcinose plutôt c'est une arthropathie chronique donc généralement on va observer l'hydrée calcique de l'endocarde-filage coccyfémoral sur les radiographies standard